·中医证候研究·

脑卒中后失语症中医证素分布与语言功能及日常生活能力的相关性研究

倪静蕾，柴林松，王梦雪，黄韵诗，熊啸，黄佳，林冰冰
（福建中医药大学康复医学院，福建福州 350122）

摘要：【目的】探讨脑卒中后失语症（PSA）患者的中医证候要素与语言功能及日常生活能力的相关性。**【方法】**选取2023年4月至2024年4月期间在福建中医药大学附属康复医院住院治疗的98例PSA患者，分析患者的语言功能特征、中医证素特征以及两者的相关性。**【结果】**（1）PSA患者中，男性患者多于女性；PSA患者在失语症相关的各个量表中表现不同，语言功能损伤主要集中在命名、自发言语等领域。（2）不同年龄段PSA患者各证素的分布不同，其中，<50岁年龄段以气闭（占100.00%）、痰证（占100.00%）、湿证（占100.00%）为主，50～59岁年龄段以痰证（占100.00%）和阳亢证（占96.30%）为主，60～69岁年龄段也以痰证（占100.00%）和阳亢证（占96.15%）为主，70～79岁年龄段以气虚证（占100.00%）为主，80～89岁年龄段的患者在气不固证、气闭证、气虚证、痰证、阳亢证、血瘀证、动风证、血寒证较为集中（均占100.00%）。但不同年龄段PSA患者中医证素分布情况比较，差异无统计学意义（$P>0.05$）。（3）不同性别PSA患者虚证、实证证素分布不同，虚证证素中，男性以阳亢、气虚、阴虚为主，女性以阳亢、气虚、血虚为主；实证证素中，男性以痰证、气闭证、湿证为主，女性以痰证、气闭证、气滞证为主。但不同性别PSA患者虚证、实证证素分布情况比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$）。（4）部分相关性分析结果：在控制PSA患者的年龄和性别因素后的偏相关分析显示，病位证素中，PSA患者波士顿命名测验（BNT）自发命名（$r=-0.588$，$P=0.027$）、BNT提示命名（$r=-0.558$，$P=0.038$）与大肠负相关；病性证素中，PSA患者BNT提示命名（$r=0.821$，$P<0.001$）与气陷正相关，BNT自发命名与血热（$r=-0.544$，$P=0.044$）负相关，与津液亏（$r=0.860$，$P=0.028$）正相关；BNT选择命名与外风（$r=0.966$，$P=0.034$）正相关；BNT提示命名错误与气陷（$r=-0.540$，$P=0.005$）负相关；改良Barthel指数（MBI）与精亏（$r=0.572$，$P=0.021$）正相关。**【结论】**PSA患者的证素主要集中在痰证、气闭、阳亢、气虚等，PSA患者语言功能及日常生活能力与中医证素有一定的相关关系。

关键词：脑卒中；失语症；中医证素；语言功能；日常生活能力；相关性分析
中图分类号：R277.7 **文献标志码：**A **文章编号：**1007-3213(2025)06-1297-09
DOI：10.13359/j.cnki.gzxbtcm.2025.06.001

Study on the Correlation of Traditional Chiense Medicine Syndrome Elements with Language Function and Activities of Daily Living in Patients Suffering Post-stroke Aphasia

NI Jinglei, CHAI Linsong, WANG Mengxue, HUANG Yunshi, XIONG Xiao, HUANG Jia, LIN Bingbing
(College of Rehabilitation Medicine, Fujian University of Traditional Chinese Medicine, Fuzhou 350122 Fujian, China)

Abstract: Objective To explore the correlation of traditional Chinese medicine (TCM) syndrome elements with language function and activities of daily living (ADL) in patients suffering post-stroke aphasia (PSA). **Methods** Ninety-eight PSA patients hospitalized at the College of Rehabilitation Medicine, Fujian University of Traditional Chinese Medicine from April 2023 to April 2024 were selected. The language function, TCM syndrome elements, and their correlations were analyzed. **Results** (1) Among PSA patients, males outnumbered females. PSA patients

收稿日期：2024-10-15
作者简介：倪静蕾（1998-），女，硕士研究生；E-mail：10661986@163.com
通信作者：林冰冰，女，讲师；E-mail：icy011@fjtcm.edu.cn
基金项目：国家自然科学基金项目（编号：82074512）；福建省科技计划项目社会发展引导性（重点）项目（编号：2023Y0035）；福建中医药大学康复技术协同创新中心项目（编号：X2022011）

中国知网 https://www.cnki.net

exhibited different performances on various aphasia-related scales, with language impairments mainly concentrated in naming and spontaneous speech. (2) The distribution of TCM syndrome elements varied in PSA patients with different age groups. In the age group <50 years old, *qi* obstruction (100.00%), phlegm syndrome (100.00%), and dampness syndrome (100.00%) were predominant. In the age group of 50-59 years old, phlegm syndrome (100.00%) and yang hyperactivity syndrome (96.30%) were predominant. In the age group of 60-69 years old, phlegm syndrome (100.00%) and yang hyperactivity syndrome (96.15%) were also predominant. In the age group of 70-79 years old, *qi* deficiency syndrome (100.00%) was predominant. In the age group of 80-89 years old, syndromes such as *qi* insecurity, *qi* obstruction, *qi* deficiency, phlegm, yang hyperactivity, blood stasis, wind stirring, and blood cold were concentrated (all 100.00%). However, there were no statistically significant differences in the distribution of TCM syndrome elements among various age groups ($P > 0.05$). (3) The distribution of deficiency and excess syndrome elements varied in PSA patients with different genders. Among deficiency syndrome elements, yang hyperactivity, *qi* deficiency, and yin deficiency were predominant in males, while yang hyperactivity, *qi* deficiency, and blood deficiency were predominant in females. Among excess syndrome elements, phlegm syndrome, *qi* obstruction, and dampness syndrome were predominant in males, while phlegm syndrome, *qi* obstruction, and *qi* stagnation syndrome were predominant in females. However, there were no statistically significant differences in the distribution of deficiency and excess syndrome elements between genders ($P > 0.05$). (4) After controlling the factors of age group and gender, partial correlation analysis of syndrome elements and language function showed that among the disease-location syndrome elements, spontaneous naming ($r = -0.588$, $P = 0.027$) and sematic cued naming ($r = -0.558$, $P = 0.038$) in the Boston Naming Test (BNT) were negatively correlated with the large intestine; among the disease-nature syndrome elements, BNT sematic cued naming ($r = 0.821$, $P < 0.001$) was positively correlated with *qi* sinking, while BNT spontaneous naming was negatively correlated with blood heat ($r = -0.544$, $P = 0.044$) and was positively correlated with fluid depletion ($r = 0.860$, $P = 0.028$); BNT recognitive naming was positively correlated with external wind ($r = 0.966$, $P = 0.034$); errors in BNT sematic cued naming were negatively correlated with *qi* sinking ($r = -0.540$, $P = 0.005$); the Modified Barthel Index (MBI) was positively correlated with essence deficiency ($r = 0.572$, $P = 0.021$). **Conclusion** The TCM syndrome elements of phlegm, *qi* block, yang hyperactivity, and *qi* deficiency are commonly seen in PSA patients. There is a certain correlation of language function and ADL with TCM syndrome elements in PSA patients.

Keywords: stroke; aphasia; traditional Chinese medicine syndrome elements; language function; activities of daily living (ADL); correlation analysis

脑卒中后失语症(post-stroke aphasia, PSA)是常见的脑卒中后遗症之一，发病率约占脑卒中人群的20%～40%[1-2]，临床主要表现为语言表达能力及理解能力受损，对日常生活交流产生严重影响。脑卒中在中医学归属于“中风”范畴，其病机主要涉及风、火、痰、瘀、虚五端，这些病理因素在一定程度下互相转化，引起内风扰动、阴阳失调、气血逆乱，从而导致“脑脉痹阻”(缺血性脑卒中)或“血溢脑脉之外”(出血性脑卒中)[3]。《灵枢·忧恚无言》曰：“舌者，音声之机也……横骨者，神气之所使也，主发舌者也”[4]。这表明语言等发声活动受“神”之所主。《素问·五脏生成》曰：“诸髓者，皆属于脑”[4]。《三因极一病证方论》则云：“头者，诸阳之会……百神所集”[5]。故脑以“髓”为体，以“神”为用。其病在髓，其症在神。PSA发病多与脏腑功能失调、气血逆乱，上扰脑髓，神机失用，病久脏腑亏虚，脑髓失于濡养所致。作为脑卒中后遗症，在病位及病性方面，PSA的病机与脑卒中存在显著差异，并且中医证候具有机制复杂、动态演变等特点，故研究PSA证候要素的特异性具有重要的临床意义。目前，中医对PSA的辨证论治标准尚未统一，难以阐释其

中国知网 https://www.cnki.net

中医病机本质。因此，本研究根据朱文锋教授倡导的证素辨证方法，收集PSA患者的临床证候要素进行分析，以探讨PSA患者的证素分布特征及与语言功能和日常生活能力的联系，以期有助于临床构建PSA病证结合诊疗方案。

1 资料与方法

1.1 **研究对象** 选取2023年4月至2024年4月期间于福建中医药大学附属康复医院住院治疗的98例PSA患者为研究对象。其中，男性71例，女性27例，男女比例为2.63∶1；年龄29～86岁，平均年龄59.9岁；病程15～1 224 d，平均病程为121 d。本研究符合医学伦理学要求并通过福建中医药大学附属康复医院医学伦理委员会的审核批准，伦理批准号：2023KY-009-01。

1.2 **诊断标准**

1.2.1 *西医诊断标准* 参照2019年中华医学会神经病学分会以及中华医学会神经病学分会脑血管病学组撰写的《中国各类主要脑血管病诊断要点2019》[6]中有关脑卒中(包括缺血性脑卒中和出血性脑卒中)的诊断标准。

1.2.2 *中医诊断标准* 参照1996年国家中医药管理局脑病急症协作组制订的《中风病诊断与疗效评定标准(试行)》[7]中有关中风病的诊断标准。

1.3 **纳入标准** ①符合上述脑卒中的中、西医诊断要点，且经颅脑CT或MRI检查证实，属左侧大脑半球脑卒中；②经西方失语成套测验(WAB)诊断为失语症；③病程＞2周；④右利手；⑤年龄18～90岁，性别不限；⑥生命体征稳定，意识清楚，无明显视听障碍；⑦能理解和配合本试验的各项指标评定，自愿参加本研究并签署知情同意书的患者。

1.4 **排除标准** ①原发性失语症或其他疾病(如脑外伤、脑肿瘤、脑部感染等)导致的非脑卒中后失语症患者；②构音器官器质性病变所致的言语障碍，或严重的认知功能障碍，或意识不清，或有精神病史，导致无法配合各项指标评定的患者；③存在脑卒中后严重并发症，如下肢深静脉血栓、严重呼吸系统感染、上消化道出血的患者；④患有其他严重疾病，如严重心肺功能不全、癫痫以及Ⅲ期、Ⅳ期恶性肿瘤的患者。

1.5 **信息采集与相关性分析**

1.5.1 *信息采集* 本研究参考《证素辨证学》[8]设计制作了PSA患者基本信息及证素采集表，全面收集每位患者的病史资料及证素资料，主要包括：①患者姓名、年龄、性别、现病史、既往史等内容。②根据病史资料以及中医望、闻、问、切综合提炼患者主要病位、病性证素类型；收集到患者证素后再次进行评分，得出最终证候要素评分分布情况。③根据西方失语成套测验(WAB)、波士顿命名测验(BNT)、日常生活交流能力量表(CADL)、改良Barthel指数(MBI)、脑卒中失语症生活质量量表(SAQOL-39g)等量表对患者语言功能、日常生活交流能力、日常生活质量、日常生活能力进行评估。

1.5.2 *相关性分析* 采用Pearson及Spearman分析，在控制PSA患者的年龄和性别因素后，分析PSA患者病位、病性证素与语言功能及日常生活能力的相关性。

1.6 **统计方法** 采用Excel表建立数据库，对所有采集的数据进行校正核对，应用SPSS 26.0软件进行数据的统计分析。计数资料用频数及百分比表示，正态分布的计量资料用均数±标准差($\bar{x} \pm s$)表示，偏态分布的计量资料用中位数和四分位数[$M(P_{25}, P_{75})$]表示。采用χ^2检验、t检验及秩和检验进行数据统计分析，采用Pearson及Spearman分析进行相关性分析。所有检验标准均以$P<0.05$为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 **基本资料** 本研究共纳入98例PSA患者，其中，男性71例，女性27例；所有PSA患者的平均年龄为59.9岁，男性平均年龄为59.3岁，女性平均年龄为63.5岁。其中，≤50岁年龄段20例，占总人数的20.41%；50～59岁年龄段27例，占27.55%；60～69岁年龄段26例，占26.53%；70～79岁年龄段21例，占21.43%；80～89岁年龄段4例，占4.08%。

2.2 **语言功能及日常生活能力特征分析** 结果见表1。PSA患者在失语症相关的各个量表中表现不同，语言功能损伤主要集中在命名、自发言语等领域。BNT命名测试中，命名功能缺陷主要集中在BNT提示命名，得分占9.60%，BNT自发命名，得分占15.00%，BNT选择命名，得分占16.83%；

中国知网 https://www.cnki.net

表1 脑卒中后失语症(PSA)患者语言功能及日常生活能力特征

Table 1 Scoring of language function and activities of daily living of patients with post-stroke aphasia (PSA)

项目	得分[$\bar{x} \pm s$或$M(P_{25}, P_{75})$]/分	得分占比/%
WAB总分	159.19(64.00, 164.50)	36.85
WAB自发言语	5.70(2.00, 9.00)	28.00
WAB听理解	98.35(51.75, 154.75)	48.18
WAB复述	31.54 ± 33.15	31.54
WAB命名	22.35(0.00, 38.75)	21.29
BNT自发命名	4.50 ± 6.16	15.00
BNT选择命名	5.05 ± 5.39	16.83
BNT提示命名	2.88 ± 2.77	9.60
BNT提示命名错误	17.38 ± 8.81	57.94
CADL	33.93 ± 33.63	24.95
MBI	46.79 ± 33.28	46.79
SAQOL-39g	80.55 ± 30.98	41.31

注：WAB：西方失语成套测验；BNT：波士顿命名测验；CADL：日常生活交流能力量表；MBI：改良Barthel指数；SAQOL-39g：脑卒中失语症生活质量量表。

WAB测试中，语言功能的主要缺陷同样集中在命名功能，WAB命名得分占21.29%，WAB自发言语得分占28.00%，WAB复述得分占31.54%，WAB听理解得分占48.18%，而WAB总分得分占36.85%；此外，CADL的得分占24.95%，SAQOL-39g的得分占41.31%，MBI的得分占46.79%。

2.3 **不同年龄段患者各证素的频次分布情况** 结果见表2。不同年龄段PSA患者各证素的分布不同，其中，<50岁年龄段以气闭(占100.00%)、痰证(占100.00%)、湿证(占100.00%)为主，50~59岁年龄段以痰证(占100.00%)和阳亢证(占96.30%)为主，60~69岁年龄段也以痰证(占100.00%)和阳亢证(占96.15%)为主，70~79岁年龄段以气虚证(占100.00%)为主，80~89岁年龄段的患者在气不固证、气闭证、气虚证、痰证、阳亢证、血瘀证、动风证、血寒证较为集中(均占100.00%)。但不同年龄段PSA患者中医证素分布情况比较，差异无统计学意义($P > 0.05$)。

表2 不同年龄段脑卒中后失语症(PSA)患者各证素的频次分布情况

Table 2 Frequency distribution of each syndrome element in patients with post-stroke aphasia (PSA) at different age groups

[例(%)]

证素	<50岁(20例)	50~59岁(27例)	60~69岁(26例)	70~79岁(21例)	80~89岁(4例)	合计(98例)
寒	18(90.00)	22(71.48)	21(80.77)	14(66.67)	2(50.00)	77(78.57)
外风	0(0.00)	2(7.41)	2(7.69)	1(4.76)	1(25.00)	6(6.12)
血寒	18(90.00)	22(71.48)	20(76.92)	14(66.67)	4(100.00)	78(79.59)
火(热)	12(60.00)	21(77.78)	20(76.92)	17(80.95)	2(50.00)	72(73.47)
血热	1(5.00)	4(14.81)	6(23.08)	5(23.81)	0(0.00)	16(16.33)
暑	12(60.00)	16(59.26)	15(57.69)	15(71.43)	3(75.00)	61(62.24)
燥	10(50.00)	12(44.44)	13(50.00)	13(61.90)	3(75.00)	51(52.04)
湿	20(100.00)	25(92.59)	22(84.62)	20(95.24)	2(50.00)	89(90.82)
痰	20(100.00)	27(100.00)	26(100.00)	21(100.00)	4(100.00)	98(100.00)
饮	4(20.00)	5(18.52)	3(11.54)	8(38.10)	1(25.00)	21(21.43)
水停	8(40.00)	11(40.74)	12(46.15)	12(57.14)	2(50.00)	45(45.92)
气滞	18(90.00)	24(88.89)	23(88.46)	19(90.48)	3(75.00)	87(88.78)
气闭	20(100.00)	24(88.89)	24(92.31)	19(90.48)	4(100.00)	91(92.86)
血瘀	13(65.00)	25(92.59)	14(53.85)	18(85.71)	4(100.00)	74(75.51)
食积	1(5.00)	2(7.41)	4(15.38)	4(19.05)	1(25.00)	12(12.24)
阳亢	17(85.00)	26(96.30)	25(96.15)	19(90.48)	4(100.00)	91(92.86)
气虚	15(75.00)	25(92.59)	22(84.62)	21(100.00)	4(100.00)	87(88.78)
气陷	4(20.00)	6(22.22)	8(30.77)	8(38.10)	1(25.00)	27(27.55)
气不固	4(20.00)	5(18.52)	6(23.08)	9(42.86)	4(100.00)	28(28.57)
血虚	15(75.00)	22(81.48)	22(84.62)	19(90.48)	0(0.00)	78(79.59)
气脱	3(15.00)	0(0.00)	0(0.00)	1(4.76)	3(75.00)	7(7.14)

中国知网 https://www.cnki.net

（续表2）

证素	<50岁（20例）	50～59岁（27例）	60～69岁（26例）	70～79岁（21例）	80～89岁（4例）	合计（98例）
阳虚	10（50.00）	12（44.44）	7（26.92）	8（38.10）	1（25.00）	38（38.78）
亡阳	3（15.00）	0（0.00）	0（0.00）	2（9.52）	0（0.00）	5（5.10）
阴虚	13（65.00）	23（85.19）	18（69.23）	19（90.48）	3（75.00）	76（77.55）
津液亏	0（0.00）	3（11.11）	3（11.54）	2（9.52）	0（0.00）	8（8.16）
亡阴	0（0.00）	1（3.70）	1（3.85）	1（4.76）	0（0.00）	3（3.06）
精亏	2（10.00）	5（18.52）	6（23.08）	4（19.05）	1（25.00）	18（18.37）
动风	13（65.00）	23（85.19）	19（73.08）	17（80.95）	4（100.00）	76（77.55）
动血	2（10.00）	5（18.52）	5（19.23）	8（38.10）	1（25.00）	21（21.43）
毒	2（10.00）	2（7.41）	2（7.69）	2（9.52）	0（0.00）	8（8.16）
脓	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	1（4.76）	0（0.00）	1（1.02）
阳浮	0（0.00）	1（3.70）	0（0.00）	1（4.76）	0（0.00）	2（2.04）
虫积	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）	0（0.00）
χ^2值						119.976
P值						0.585

2.4 不同性别患者虚证、实证证素分布情况 结果见表3和表4。不同性别PSA患者虚证、实证证素分布不同，虚证证素中，男性以阳亢、气虚、阴虚为主，女性以阳亢、气虚、血虚为主；实证证素中，男性以痰证、气闭证、湿证为主，女性以痰证、气闭证、气滞证、血瘀证为主。但不同性别PSA患者虚证、实证证素分布比较，差异均无统计学意义（$P>0.05$）。

2.5 病位、病性证素与语言功能及日常生活能力相关性分析 结果见表5和表6。在控制PSA患者

表3 不同性别脑卒中后失语症（PSA）患者虚证证素分布情况

Table 3 Distribution of deficiency syndrome elements in patients with post-stroke aphasia (PSA) of different genders

[例（%）]

性别	例数/例	气虚	气陷	气不固	气脱	血虚	阳虚	阳亢	亡阳	阳浮	阴虚	津(液)亏	亡阴	精亏
男性	71	60（84.51）	16（22.54）	18（25.35）	4（5.63）	54（76.06）	29（40.85）	66（92.96）	4（5.63）	2（2.82）	57（80.28）	5（7.04）	3（4.23）	13（18.31）
女性	27	27（100.00）	11（40.74）	10（37.04）	3（11.11）	24（88.89）	9（33.33）	27（100.00）	1（3.70）	0（0.00）	19（70.37）	3（11.11）	0（0.00）	5（18.52）
合计	98	87（88.78）	27（27.55）	28（28.57）	7（7.14）	78（79.59）	38（38.78）	93（94.90）	5（5.10）	2（2.04）	76（77.55）	8（8.16）	3（3.06）	18（18.37）
χ^2值														7.966
P值														0.716

表4 不同性别脑卒中后失语症（PSA）患者实证证素分布情况

Table 4 Distribution of excess syndrome elements in patients with post-stroke aphasia (PSA) of different genders

[例（%）]

性别	例数/例	外风	寒	血寒	火（热）	血热	暑	燥	湿	痰
男性	71	5（7.04）	55（77.46）	55（77.46）	53（74.65）	12（16.90）	42（59.15）	34（47.89）	66（92.96）	71（100.00）
女性	27	1（3.70）	22（81.48）	23（85.19）	19（70.37）	4（14.81）	19（70.37）	17（62.96）	23（85.19）	27（100.00）
合计	98	6（6.12）	77（78.57）	78（79.59）	72（73.47）	16（16.33）	61（62.24）	51（52.04）	89（90.82）	98（100.00）

性别	例数/例	饮	水停	气滞	气闭	血瘀	脓	食积	动血	毒
男性	71	15（21.13）	32（45.07）	63（88.73）	66（92.96）	50（70.42）	1（1.41）	11（15.49）	12（16.90）	5（7.04）
女性	27	6（22.22）	13（48.15）	24（88.89）	25（92.59）	24（88.89）	0（0.00）	1（3.70）	9（33.33）	3（11.11）
合计	98	21（21.43）	45（45.92）	87（88.78）	91（92.86）	74（75.51）	1（1.02）	12（12.24）	21（21.43）	8（8.16）
χ^2值										7.771
P值										0.989

中国知网 https://www.cnki.net

的年龄和性别因素后的偏相关分析显示，病位证素中，PSA患者WAB总分($r = -0.309$，$P = 0.016$)、WAB自发言语($r = -0.323$，$P = 0.012$)、WAB复述($r = -0.277$，$P = 0.032$)、WAB命名($r = -0.299$，$P = 0.021$)、BNT自发命名($r = -0.390$，$P = 0.002$)、BNT提示命名($r = -0.324$，$P = 0.012$)、CADL($r = -0.277$，$P = 0.032$)与胸膈负相关，BNT提示命名错误($r = 0.259$，$P = 0.046$)与胸膈正相关；WAB听理解($r = -0.454$，$P = 0.039$)与胆负相关；BNT自发命名与心神($r = 0.203$，$P = 0.047$)、心($r = 0.256$，$P = 0.030$)正相关，与大肠($r = -0.588$，$P = 0.027$)负相关；BNT选择命名与筋骨($r = 0.459$，$P = 0.003$)正相关；BNT提示命名与大肠($r = -0.558$，$P = 0.038$)负相关；MBI与肺($r = -0.328$，$P = 0.026$)负相关，与膀胱($r = 0.467$，$P = 0.021$)正相关；SAQOL-39g总分与膀胱($r = 0.519$，$P = 0.009$)正相关，与胸膈($r = -0.285$，$P = 0.027$)负相关。

病性证素中，PSA患者WAB总分($r = 0.419$，$P = 0.037$)、WAB复述($r = 0.430$，$P = 0.032$)、WAB命名($r = 0.483$，$P = 0.014$)、BNT提示命名($r = 0.821$，$P < 0.001$)与气陷正相关，BNT自发命名与血热($r = -0.544$，$P = 0.044$)负相关，与津液亏($r = 0.860$，$P = 0.028$)正相关；BNT选择命名与外风($r = 0.966$，$P = 0.034$)正相关，与水停($r = -0.344$，$P = 0.037$)负相关；BNT提示命名错误与痰($r = 0.211$，$P = 0.039$)正相关，与气陷($r = -0.540$，$P = 0.005$)负相关；CADL与气陷($r = 0.498$，$P = 0.011$)正相关；MBI与气陷($r = -0.471$，$P = 0.018$)负相关，与精亏($r = 0.572$，$P = 0.021$)正相关。

3 讨论

我国脑卒中患病率整体呈上升趋势，脑卒中现患病人数高居世界首位，并存在显著的性别及年龄差异[9]，脑卒中后失语症(PSA)作为脑卒中后常见的功能障碍，严重影响脑卒中患者个体预后[10]。本研究对PSA患者的基本信息分析发现，PSA患者男性患病人数较高，与既往研究结果[11]一致，可能与男性饮食习惯、运动习惯、烟酒嗜好等因素有关。此外，50～79岁年龄段的患者占比较大，提示应关注50岁以上的男性群体，及时采取饮食、运动调节，戒除不良嗜好等有效的防御措施，实现“未病先防”以减少PSA的发病。

既往研究将PSA的病机主要归为“本虚标实”，发病多以肝肾阴虚、气血不足为本，以风、火、痰、瘀等为标[12]，这与本研究结果一致。此外，本研究探讨了不同年龄段PSA患者的证素分

表5 脑卒中后失语症(PSA)病位证素与语言功能及日常生活能力相关性分析

Table 5 Analysis of the correlation of disease-location syndrome elements with language function and activities of daily living in patients with post-stroke aphasia (PSA)

项目	心神		心		肺		胆		大肠		膀胱		胸膈		筋骨	
	r值	P值	r值	P值	r值	P值	r值	P值	r值	P值	r值	P值	r值	P值	r值	P值
WAB总分	-0.064	0.534	-0.035	0.772	-0.141	0.352	-0.391	0.079	-0.184	0.530	-0.190	0.374	-0.309	0.016	0.064	0.697
WAB自发言语	-0.040	0.697	0.012	0.923	-0.148	0.327	-0.174	0.452	-0.098	0.739	-0.290	0.169	-0.323	0.012	0.103	0.529
WAB听理解	-0.026	0.802	-0.015	0.901	-0.223	0.136	-0.454	0.039	-0.256	0.376	-0.227	0.287	-0.252	0.052	0.096	0.555
WAB复述	-0.107	0.299	-0.065	0.590	0.053	0.727	-0.186	0.420	-0.050	0.864	-0.044	0.837	-0.277	0.032	-0.035	0.829
WAB命名	-0.065	0.531	-0.029	0.810	-0.094	0.536	-0.317	0.161	-0.120	0.683	-0.216	0.310	-0.299	0.021	0.081	0.619
BNT自发命名	0.203	0.047	0.256	0.030	-0.070	0.642	0.035	0.881	-0.588	0.027	0.097	0.653	-0.390	0.002	-0.235	0.144
BNT选择命名	-0.142	0.169	-0.212	0.073	-0.061	0.689	-0.163	0.481	0.011	0.970	0.289	0.171	0.033	0.804	0.459	0.003
BNT提示命名	0.029	0.781	0.108	0.365	-0.146	0.332	-0.125	0.589	-0.558	0.038	-0.115	0.594	-0.324	0.012	-0.088	0.589
BNT提示命名错误	-0.057	0.583	-0.081	0.500	0.143	0.344	0.155	0.501	0.452	0.104	-0.058	0.786	0.259	0.046	-0.054	0.741
CADL	0.004	0.967	0.007	0.953	-0.121	0.423	-0.363	0.106	-0.101	0.730	-0.362	0.082	-0.277	0.032	0.098	0.547
MBI	-0.093	0.368	-0.130	0.275	-0.328	0.026	-0.259	0.257	-0.054	0.855	0.467	0.021	-0.231	0.075	-0.122	0.453
SAQOL-39g	0.049	0.632	0.008	0.944	-0.273	0.066	-0.260	0.256	-0.346	0.225	0.519	0.009	-0.285	0.027	-0.053	0.745

注：WAB：西方失语成套测验；BNT：波士顿命名测验；CADL：日常生活交流能力量表；MBI：改良Barthel指数；SAQOL-39g：脑卒中失语症生活质量量表。

中国知网 https://www.cnki.net

表6 脑卒中后失语症(PSA)病性证素与语言功能及日常生活能力相关性分析

Table 6 Analysis of the correlation of disease-nature syndrome elements with language function and activities of daily living in patients with post-stroke aphasia (PSA)

项目	外风		血热		痰		水停		气陷		津液亏		精亏	
	*r*值	*P*值	*r*值	*P*值	*r*值	*P*值	*r*值	*P*值	*r*值	*P*值	*r*值	*P*值	*r*值	*P*值
WAB总分	−0.455	0.545	−0.152	0.605	−0.151	0.143	−0.027	0.874	0.419	0.037	0.620	0.189	−0.394	0.131
WAB自发言语	−0.508	0.492	−0.004	0.989	−0.193	0.059	0.067	0.694	0.372	0.067	0.583	0.224	−0.277	0.299
WAB听理解	−0.289	0.711	−0.273	0.344	−0.112	0.278	−0.033	0.846	0.301	0.143	0.578	0.229	−0.397	0.128
WAB复述	−0.541	0.459	−0.095	0.747	−0.120	0.245	−0.030	0.858	0.430	0.032	0.679	0.138	−0.422	0.104
WAB命名	−0.566	0.434	0.030	0.919	−0.191	0.063	0.003	0.985	0.483	0.014	0.538	0.271	−0.206	0.443
BNT自发命名	0.170	0.830	−0.544	0.044	−0.163	0.112	0.192	0.256	0.336	0.100	0.860	0.028	−0.194	0.471
BNT选择命名	0.966	0.034	0.467	0.092	−0.068	0.513	−0.345	0.037	−0.095	0.651	−0.010	0.985	−0.061	0.822
BNT提示命名	0.047	0.953	0.182	0.533	−0.180	0.079	0.130	0.445	0.821	0.000	0.542	0.267	−0.213	0.428
BNT提示命名错误	−0.365	0.635	0.346	0.225	0.211	0.039	−0.049	0.772	−0.540	0.005	−0.502	0.310	0.192	0.476
CADL	−0.504	0.496	−0.164	0.576	−0.186	0.070	0.093	0.585	0.498	0.011	0.596	0.212	−0.197	0.465
MBI	0.875	0.125	−0.123	0.676	−0.079	0.444	−0.013	0.940	−0.471	0.018	−0.197	0.708	0.572	0.021
SAQOL-39g	−0.002	0.998	−0.389	0.169	−0.174	0.089	0.259	0.121	−0.282	0.172	0.347	0.500	0.276	0.301

注：WAB：西方失语成套测验；BNT：波士顿命名测验；CADL：日常生活交流能力量表；MBI：改良Barthel指数；SAQOL-39g：脑卒中失语症生活质量量表。

布，结果显示，<50岁年龄段及50~59岁年龄段的患者以气闭、痰证等实证为主；60~69岁年龄段、69~79岁年龄段及79~89岁年龄段的患者以阳亢、气虚等虚证为主。此外，不同性别患者的虚证、实证证素分布也稍有不同。本研究结果正与不同年龄及性别的体质变化规律相关，相对于老年人的虚性体质，中年人的实证证素更为显著。60岁以下患者体质尚实，该年龄段患者发病多为脏腑功能失调，气血逆乱，风火痰瘀等壅滞清窍，神机失用。而大于60岁年龄段的患者体质多虚，或因后天脾胃虚极、难以运化水谷，或因先天肝肾虚耗、精气难固，脑髓难以受精微、肾精之濡养，此时复感毒邪，则空疏不复，神机不得施[13]。本病虚证多见年老体衰者，究其根源，乃肝肾耗损，肾精阴血亏虚，肝阴滋养匮乏，脑髓失养所致[14]。宋代医家许叔微言："男子以精为主，女子以血为本。"本研究结果也体现了这一观点，在虚证证素中，男性多见阴虚，女性多见血虚。而实证则多见中风后脏腑失调，气机逆乱，痰浊上蒙，气机痹阻，脑髓失于濡养而见本病[13]。并且，男性主要表现为湿证，可能与其饮食嗜好相关；而女性主要表现为气滞证，中医学认为，妇人多郁怒、思虑和惊恐之证，故多表现为肝郁气滞之证[15]。此外，高年龄段患者的证素频次分布更为复杂，可能是由于高龄患者体质衰弱，病理因素较为复杂，同时也可能与本研究纳入的该年龄段患者人数较少有关。

西方失语成套测验(WAB)、波士顿命名测验(BNT)目前常用于成人失语的检查，WAB包含多项语言评估分测验，其中包括自发言语、听觉理解、复述检查、命名检查[16]。由于几乎所有失语症患者均有不同程度的命名障碍，并贯穿病程的始终[17]。本研究采用BNT对PSA患者的命名功能进行了进一步评估。BNT是评估视觉对抗命名的最广泛使用的测试，已被改编成多种语言，在临床有着广泛应用[18]。改良Barthel指数(MBI)、日常生活交流能力量表(CADL)及脑卒中失语症生活质量量表(SAQOL-39g)分别用于评估PSA患者的日常生活能力、沟通能力以及生活质量[19-21]，以全面了解PSA患者的功能损伤情况以及对日常生活的影响。在本研究中，PSA患者的语言功能损伤主要体现在命名、自发言语、听理解等领域，与既往研究[22]一致；此外，相较于MBI与SAQOL-39g，CADL得分占比较低，这也体现了失语对日常生活沟通能力的严重损害，提示临床对PSA的早期防治过程中，应密切关注该维度的训练与治疗，以期达到理想的长期康复目标[23]。

本研究通过偏相关分析发现，PSA患者WAB

中国知网 https://www.cnki.net

总分、WAB自发言语、WAB复述、WAB命名、BNT自发命名、SAQOL-39g总分与胸膈负相关；WAB听理解与胆负相关；BNT自发命名与心神、心正相关，与大肠负相关；BNT选择命名与筋骨正相关；BNT提示命名与大肠负相关；MBI与肺负相关、与膀胱正相关；WAB总分、WAB复述、WAB命名、BNT选择命名与气陷正相关，BNT自发命名与血热负相关，与津液亏正相关；BNT选择命名与外风正相关，与水停负相关；BNT提示命名错误与痰正相关，与气陷负相关；CADL与气陷正相关；MBI与气陷负相关，与精亏正相关。分析其原因：《灵枢·邪客》云："宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉"，强调宗气的升降及心神的主使在语言功能中的作用[24]。脑卒中后脏腑失养，心、肺、大肠、胸膈受病，导致宗气不能正常升降，进而导致神机失用，不能正常命名及表达，难以维持正常生活质量。并且，脑髓失于津液濡养，则脑髓不足，元神失养，言语不畅，语言功能及日常生活能力不仅需要津液濡养，亦需要津液的正常运行[25]。胆与膀胱受病，津液不能正常输布，则脑髓不得濡养，功能受限。此外，血热易扰心神，痰浊、水停等不仅仅是病理产物，更是致病之因，痰阻气机，阻滞舌本脉络，导致语言謇涩[26]。既往研究[3]发现，脑梗死患者初发以痰热腑实、风痰阻络等证居多，经治疗后，实证比例逐渐下降，虚证逐渐显露，多见气虚、气陷，进而影响身体各项机能，包括语言能力。中医证素和多个维度的语言功能以及日常生活各项能力的损害存在一定相关性，在PSA的治疗中应加以重视。

近年来，有较多脑卒中及脑卒中后遗症或并发症的中医证候研究，如罗菁等[27]对70例中风后吞咽障碍患者的中医证型构成以及各证型间患者的年龄、性别、吞咽功能及营养状况差异进行分析，该研究结果中证型构成与《中风病中医诊断、疗效评定标准》中风中经络的辨证分型趋于一致；庄丽华等[28]对中风中经络患者急性期中医证候要素与炎症反应特点进行相关性研究，以关注急性期患者的病情动态变化等；刘晓菲[29]对缺血性脑卒中后失眠患者的证素分布及相关性进行研究，指出了脑卒中后失眠患者的主要病位、病性证素。脑卒中患者遗留诸多功能障碍，但目前研究较多关注脑卒中疾病本身的证候要素分布特点，难以区分脑卒中后各并发症的证素特征及其与各项功能的相关性。此外，在疾病进展过程中，各个阶段证候不一，因此需要把握不同阶段、不同类型后遗症的证素分布特点，以提供更为精确的康复治疗方案。目前尚无PSA的证素及语言功能相关性研究，本研究通过WAB、BNT等量表评分初步探讨了各语言维度与中医证候要素的关系，可为PSA患者后期的中西医结合康复治疗提供新的思路和借鉴。此外，随着神经影像等技术的发展，临床对疾病的认识不断提高，未来对PSA病理类型相关的核心中医病机有待进一步深入研究，从而有助于深化病证结合的中西医结合诊疗。

参考文献：

[1] 于可，张超，徐凯. 卒中后失语症治疗前后功能磁共振研究进展[J]. 磁共振成像，2020，11(10)：937-939.

[2] 张梦琴，何小俊，李薇薇，等. 言语-语言治疗在卒中后失语症中的应用进展[J]. 中国实用神经疾病杂志，2024，27(4)：508-513.

[3] 高颖. 基于中医整体观构建脑卒中病证结合诊疗方案的思路[J]. 北京中医药大学学报，2024，47(1)：4-8.

[4] 佚名. 黄帝内经[M]. 北京：中医古籍出版社，2021.

[5] 陈无择. 三因极一病证方论[M]. 北京：中国中医药出版社，2007.

[6] 中华医学会神经病学分会，中华医学会神经病学分会脑血管病学组. 中国各类主要脑血管病诊断要点2019[J]. 中华神经科杂志，2019，52(9)：710-715.

[7] 李平，吴钟璇，张云如，等. 中风病诊断与疗效评定标准(试行)[J]. 北京中医药大学学报，1996，19(1)：55-56.

[8] 朱文锋. 证素辨证学[M]. 北京：人民卫生出版社，2008.

[9] 王陇德，彭斌，张鸿祺，等.《中国脑卒中防治报告2020》概要[J]. 中国脑血管病杂志，2022，19(2)：136-144.

[10] 张通，李胜利，白玉龙，等. 卒中后失语临床管理专家共识[J]. 中国康复理论与实践，2022，28(1)：15-23.

[11] 李鸿章，李彦杰，秦合伟，等. 邵氏五针法联合语言康复训练治疗脑卒中后运动性失语症患者的临床研究[J]. 南京中医药大学学报，2021，37(4)：491-496.

[12] 姜晓丽，王盛春. 针刺治疗脑卒中后运动性失语临床研究进展[J]. 国际中医中药杂志，2022，44(7)：830-833.

[13] 曹云，黄佳钦，张丹莉，等. 脑-肠互动理论下应用"益髓醒神调枢"法治疗卒中后失语的机理探讨[J]. 中华中医药杂志，2021，36(12)：7103-7107.

[14] 王海芳，徐敏杰，常静玲. 常静玲教授基于"脑-肾-髓"理论辨证论治中风后失语的经验[J]. 中国医药导报，2023，20(33)：138-142.

[15] 刘欢乐，卫拂晓，范毓慧，等. 逍遥散治疗4种肝郁气滞型妇科疾病的网络药理学作用机制研究[J]. 中国药学杂志，2021，56(14)：1138-1148.

[16] SHEWAN C M，KERTESZ A. Reliability and validity characteristics of the Western Aphasia Battery (WAB) [J]. J Speech Hear

中国知网 https://www.cnki.net

Disord，1980，45(3)：308-324.
[17] 葛政卿，刘杰，赵莹楚，等. ICF理念下失语症命名障碍的精准康复[J]. 中国康复，2020，35(2)：65-67.
[18] HWANG Y M，NA Y，PYUN S B. Development of a categorical naming test in Korean：standardization and clinical application for patients with stroke[J]. PLoS One，2021，16(2)：e0247118.
[19] 田凤霞. 中文版脑卒中后失语症生活质量量表的信度和效度研究[J]. 护理实践与研究，2020，17(4)：10-12.
[20] 王赛华，施加加，孙莹，等. 简体版改良Barthel指数在脑卒中恢复期中的信度与效度研究[J]. 中国康复，2020，35(4)：179-182.
[21] HILARI K，BYNG S，LAMPING D L，et al. Stroke and Aphasia Quality of Life Scale-39 (SAQOL-39)：evaluation of acceptability，reliability，and validity[J]. Stroke，2003，34(8)：1944-1950.
[22] 王瑜元，孙长慧，白玉龙. 卒中后失语症患者失语症类型及严重程度影响因素的回顾性分析[J]. 中国康复，2024，39(6)：323-328.
[23] PEI S，WEIWEI L，MENGQIN Z，et al. Effect of an extension speech training program based on Chinese idioms in patients with post-stroke non-fluent aphasia：a randomized controlled trial[J]. PLoS One，2023，18(2)：e0281335.
[24] 高磊，焦静，丁玉洁，等. 通隧补肾解语汤治疗缺血性脑卒中后失语症临床研究[J]. 中国中医药现代远程教育，2023，21(16)：129-132.
[25] 刘威. 中风失语症病机的中医古代研究[D]. 郑州：河南中医学院，2014.
[26] 李晓琳，常静玲. 论中风后失语辨证中的“痰”与“窍”[J]. 中华中医药杂志，2016，31(9)：3450-3454.
[27] 罗菁，崔韶阳，王曙辉，等. 中风后吞咽障碍的中医证型分布特点初探[A]//新时代 新思维 新跨越 新发展——2019中国针灸学会年会暨40周年回顾[C]. 中国湖北武汉，2019.
[28] 庄丽华，詹松华，龚志刚，等. 中风中经络患者急性期中医证候要素与炎性反应特点及相关性研究[J]. 辽宁中医杂志，2021，48(1)：21-25.
[29] 刘晓菲. 缺血性脑卒中后失眠患者的中医证素分布特点及相关分析[D]. 北京：北京中医药大学，2018.

【责任编辑：陈建宏】

《广州中医药大学学报》征稿启事

《广州中医药大学学报》(ISSN 1007-3213/CN 44-1425/R)是由广东省教育厅主管、广州中医药大学主办的综合性中医药学术类期刊，国内外公开发行。本刊为中国科技核心期刊、T2级高质量中医药科技期刊、RCCSE中国核心学术期刊(A)、中文核心期刊(2011年版)、国家期刊方阵双效期刊，先后被国内外多个重要检索系统/数据库收录，并多次获国家、省部级优秀期刊奖项。

本刊为广大临床、教学、科研工作者提供学术交流平台，全方位、多角度报道中医药领域各学科具有前瞻性、创造性和较高学术水平的科研成果和临床诊疗经验，主要开设的栏目有：中医理论探讨、中医药临床研究、中西医结合研究、针灸与经络、中药药理、中药资源研究、南药园地、名医经验传承、中医证候研究、专家论坛、新学科与新技术、中医文献研究和岭南医学研究等。本刊为月刊，每月20日出版。邮局发行，邮发代号：国内为46-275，国外为M7077。每期定价20.00元。编辑部地址：广州市番禺区广州大学城外环东路232号，广州中医药大学办公楼722室，邮编：510006；电话：020-39354129；电子邮箱：gzzyxb@gzucm.edu.cn；投稿官网：http://xb.zyxy.com.cn。欢迎投稿！欢迎订阅！

投稿要求：(1)来稿要求立意新颖、资料真实、数据准确、方法科学、统计合理、结论合乎逻辑，文字使用规范，图表清晰、参考文献出处明确，缩略语注明中文全称，附中英文摘要、第一作者与通信作者简介(包括姓名、性别、出生年份、学历、职称等)及联系方式(电话及E-mail)。(2)来稿应经作者工作单位审核以保证稿件资料来源真实、无争议等。收到本刊收稿回执后3个月内未接到稿件处理通知者，可向本编辑部查询。如欲改投他刊，请先与本刊联系，切勿一稿多投。来稿超过6个月未与作者联系，可另投他刊。(3)依照《著作权法》，本刊将按相关规范和标准对来稿进行文字修改、删节，凡涉及原意的修改、补充或删节提请作者考虑，并退回原稿请作者修改。作者应遵守《著作权法》，避免侵犯他人知识产权，引用他人的资料应以参考文献或注释等形式标明出处。对决定录用的稿件本刊酌情收取论文版面费，并用正式函件发出录用通知，由作者签署《论文著作权》书回函同意在本刊发表，保证论文内容真实，文责自负。稿件刊出后酌致稿酬(为方便作者，稿酬已于收取版面费时扣除)，并赠当期杂志2册。(4)本刊对国家及省部委基金资助项目的稿件优先录用，请作者准确标注项目(课题)编号，并附课题资助证明复印件。(5)本刊已被国内外多家数据库收录，并已加入《中国学术期刊（光盘版）》等。凡在本刊发表的论文，其著作权归作者所有，版权属本刊所有。本刊有权将其编辑的刊物制成电子版，统一纳入相关数据库，作者如未做特殊声明则视为同意。本刊所付稿酬包含著作权使用费及数据库使用费，不再另外付酬。

·《广州中医药大学学报》编辑部·

中国知网 https://www.cnki.net